

Памятка пациенту: СИОЗСН

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина — венлафаксин, дулоксетин, милнаципран

О чём эта памятка

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) — вторая по частоте группа. К ним относятся: венлафаксин (Effexor, Велаксин), дулоксетин (Cymbalta, Симбалта), милнаципран (Иксел). Показаны при депрессии, ГТР, паническом расстройстве, социальной тревоге, хронических болевых синдромах (диабетическая нейропатия, фибромиалгия — особенно дулоксетин).

Как работают и когда ждать эффекта

СИОЗСН блокируют обратный захват серотонина и норадреналина. В низких дозах ведут себя как СИОЗС; норадренергический эффект проявляется при повышении дозы (венлафаксин ≥ 150 мг/сут).

Срок	Что происходит
1–7 дней	Возможны тошнота, потливость, головная боль, тревога. Часто выражены сильнее, чем у СИОЗС.
2–4 недели	Ослабление симптомов депрессии/тревоги.
4–8 недель	Полный терапевтический эффект. При отсутствии — обсуждение дозы или смены препарата.
6–12 мес.	Продолжительность лечения после первого эпизода.

Типичные дозы

Препарат	Старт	Терапевтическая	Макс.
Венлафаксин XR	37,5–75 мг	75–225 мг	375 мг
Дулоксетин	30 мг	60 мг	120 мг
Милнаципран	25–50 мг	100 мг	200 мг

Венлафаксин ≥ 150 мг/сут может повышать АД — контроль давления. Дулоксетин противопоказан при тяжёлой печёночной недостаточности.

Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ

✓ Можно

- Принимать утром с едой (уменьшает тошноту).
- Продолжать работу и повседневную активность.
- Заниматься спортом (даже полезно — помогает от потливости).
- Сочетать с психотерапией.

✗ Нельзя

- ИМАО — перерыв не менее 14 дней в обе стороны.
- Триптаны, трамадол, линезолид, метиленовый синий — риск серотонинового синдрома.
- Зверобой — противопоказан.
- Резко бросать — венлафаксин даёт один из самых выраженных синдромов отмены среди всех АД.
- Принимать при неконтролируемой артериальной гипертензии (венлафаксин повышает АД).

! С осторожностью

- Алкоголь — избегать, особенно с дулоксетином (риск гепатотоксичности).
- НПВС, антикоагулянты — повышают риск кровотечений.
- Кофеин — может усилить тревогу и тахикардию в начале лечения.
- При ИБС, аритмиях, глаукоме, эпилепсии — обсудить с врачом.

Побочные эффекты и как реагировать

Эффект	Что делать
Тошнота	Принимать с едой; обычно проходит за 1-2 недели.
Потливость (в т.ч. ночная)	Частый эффект СИОЗСН. Лёгкая одежда, вода. Стойкая потливость → обсудить с врачом (возможен ципрогептадин, теразозин).
Повышение (венлафаксин)	АД Контроль АД до начала и на дозах ≥ 150 мг. Домашний тонометр — норма.
Сухость во рту, запор	Вода, клетчатка. Обычно транзиторно.
Сексуальная дисфункция	До 30-50%. Часто уменьшается со временем.
Тахикардия, «сердцебиение»	Обычно мягкое. При тяжёлом — ЭКГ и консультация врача.
Головокружение, нечёткость зрения	В первые дни. Осторожность за рулём.
Инсомния или сонливость	Дулоксетин чаще седирует, венлафаксин — активирует. Смена времени приёма.

⚠ Когда СРОЧНО связаться с врачом или вызвать скорую (103 / 112)

- Мысли о самоповреждении или суициде, особенно с планом.
- Резкое возбуждение, агитация, спутанность сознания.
- Высокая температура + мышечная ригидность + потливость + дрожь + тахикардия (подозрение на серотониновый синдром).
- Сильная сыпь, отёк лица/губ, затруднённое дыхание (аллергия).
- Кровотечения: длительное носовое, кровь в стуле, обильные синяки.
- Судороги, обморок, необычно медленный или частый пульс.
- Резкое усиление тревоги/панические атаки в первые 1-2 недели (может потребоваться коррекция дозы или временное «прикрытие»).

Вождение автомобиля

- В стабильной дозе СИОЗСН не запрещают вождение (данные по венлафаксину — без ухудшения driving performance, Ramaekers).
- Первые 1–2 недели и при повышении дозы — воздержаться от длительных поездок.
- Дулоксетин может вызывать сонливость — соблюдать осторожность.
- Алкоголь + СИОЗСН + руль — нельзя.

Беременность и планирование

! Позиция современных руководств

СИОЗСН не являются препаратами первого выбора при инициации терапии во время беременности — при выборе de novo предпочтительны СИОЗС (сертралин).

Если пациентка уже стабильна на СИОЗСН, риск отмены и рецидива часто выше, чем риск продолжения — решение индивидуальное.

Венлафаксин — больше данных, приемлем при обоснованной необходимости.

Дулоксетин — данных меньше; не показано существенного увеличения тератогенности, но возможен неонатальный синдром адаптации.

Источники: NICE CG192, MotherToBaby, Eleftheriou 2023, CANMAT.

Грудное вскармливание

✓ Совместимость

- Венлафаксин — переходит в молоко в умеренных количествах; нежелательных эффектов у младенцев в исследованиях не описано, но de novo предпочтительны СИОЗС (сертралин).
- Дулоксетин — низкие уровни в молоке (относительная доза для младенца < 1%), считается совместимым по данным LactMed.
- Наблюдать за младенцем: сон, аппетит, беспокойство.

Источники: LactMed (NIH), UK SPS 2023.

Отмена и синдром отмены

Венлафаксин известен одним из самых тяжёлых синдромов отмены (короткий $T_{1/2}$). Симптомы могут возникнуть уже через 8–12 часов после пропуска дозы: головокружение, «brain zaps», тошнота, тревога, плаксивость.

- Только постепенное снижение под контролем врача — обычно 25% дозы каждые 2–4 недели, часто медленнее.
- Для венлафаксина иногда переводят на флуоксетин на период финальной отмены (длинный $T_{1/2}$ смягчает синдром отмены).
- Никогда не бросайте резко, даже если «хорошо себя чувствуете».

Развенчание мифов

Развенчание мифов

Миф: «Венлафаксин — «тяжёлый», значит опасный»

На самом деле: «Тяжёлый» = более выраженный синдром отмены при неправильном прекращении. По эффективности венлафаксин — один из самых сильных АД (Cipriani et al., Lancet 2018).

Миф: «Дулоксетин — обезболивающее, а не АД»

На самом деле: Он и то, и другое. Дулоксетин полноценно лечит депрессию и ГТР и одновременно эффективен при нейропатической боли и фибромиалгии.

Миф: «СИОЗСН провоцируют гипертонию»

На самом деле: Только венлафаксин на дозах ≥ 150 мг у части пациентов даёт умеренное повышение АД — это контролируется.

Миф: «Их нельзя отменить»

На самом деле: Можно, но медленно и по схеме врача.

Частые вопросы

? Частые вопросы (FAQ)

Я пропустил дозу — что делать?

Принять как можно скорее. Если до следующей осталось < 4 часов (для венлафаксина < 6) — пропустить и продолжать. Не удваивать.

Почему у меня сильная потливость?

Классический эффект СИОЗСН (норадренергический компонент). Обычно уменьшается со временем; при выраженной — сообщите врачу.

Могу ли я пить кофе?

Да, но умеренно (до 2 чашек). В начале терапии кофеин может усилить тахикардию и тревогу.

Дулоксетин и алкоголь — правда, что нельзя?

Есть данные о повышении риска гепатотоксичности при сочетании. Лучше полностью воздержаться, особенно если пьёте регулярно.

Помогает ли дулоксетин от боли в спине?

При хронической скелетно-мышечной боли — есть умеренные доказательства эффективности. Обсудите с врачом.

А если препарат перестал работать?

«Роор-out» встречается. Врач оценит комплаенс, дозу, сопутствующие факторы и при необходимости сменит препарат.

Питание и образ жизни

Антидепрессант работает лучше, если помогать ему извне. Ниже — то, что имеет доказательную базу (не БАДы, не «волшебные» диеты).

Питание

- Средиземноморский тип питания (овощи, рыба, оливковое масло, бобовые, цельные злаки, орехи) — единственный тип питания с доказанным умеренным антидепрессивным эффектом (SMILES trial, 2017; PREDIMED).

- Омега-3 (жирная рыба 2 раза в неделю) — вспомогательный эффект при депрессии, особенно EPA-обогащённые формы.
- Регулярность приёмов пищи: пропуск еды усиливает тошноту и головокружение от многих АД.
- Достаточно воды (1,5–2 л/сут) — уменьшает сухость во рту и запоры.

Кофеин и энергетики

- До 200–300 мг кофеина в сутки (2–3 чашки кофе) — обычно безопасно.
- При выраженной тревоге и бессоннице лучше отказаться от кофе после 14:00.
- Энергетики и предтренировочные комплексы нежелательны — содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, усиливают тревогу и сердцебиение.

Сон

- Ложиться и вставать в одно и то же время (± 30 мин), даже в выходные.
- Экран за 30–60 минут до сна — выключить. Синий свет подавляет мелатонин.
- Если препарат бодрит (флуоксетин, венлафаксин, бупропион) — принимать утром. Если седирует (миртазапин, тразодон, амитриптилин, пароксетин) — вечером.

Физическая активность

- 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед) — эффект сопоставим с лёгкими формами депрессии на монотерапии (Cochrane, 2013; meta-analyses 2023).
- Силовые тренировки 2 раза в неделю — дополнительный эффект на тревогу и самооценку.
- Начинать с малого: 10 минут в день — уже работает.

Дисклеймер. Этот документ — информационная памятка, а не медицинская инструкция. Все решения о начале, изменении дозы и отмене препарата принимаются только совместно с лечащим врачом. Материал подготовлен на основе современных источников: NICE NG222 (2022–2024), APA Practice Guidelines, WFSBP, Maudsley Prescribing Guidelines (14-е изд.), NIH LactMed, MotherToBaby, Cochrane Reviews.